1.掌深间隙感染

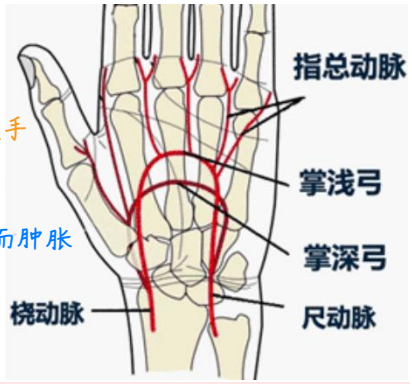
①掌中间隙感染：**掌心凹消失（掌心隆起）**，3/4/5 指活动受限（掌中-中指）

②鱼际间隙感染：**鱼际肿胀，1/2 指活动受限、不能对掌**（算命）正中神经损伤，大鱼际萎缩→猿手

③肿痛明显时：及时切开引流。切口近端不及掌横纹（避免损伤掌浅弓）

④**严禁切开肿胀的手背**

病变本身在手掌，因手掌角化坚韧，手背薄弱松弛，手掌感染易通过淋巴管到达手背进而肿胀



2.化脓性腱鞘炎（不是狭窄性腱鞘炎）无菌性炎症（运动系统慢性损伤）

①可致掌深间隙感染：2 指蔓延至鱼际间隙、3/4 指蔓延至掌中间隙

②可致滑囊炎：1/5 指分别蔓延至桡、尺侧滑囊

③肿痛明显时：及时切开引流，否则易致肌腱缺血坏死

④术后抬高患手、固定在功能位（促进回流）

手部的化脓性感染，除了甲沟炎是等到波动感形成后切开引流，其他的手部位化脓性感染都是肿痛明显及时切开引流

VS狭窄性腱鞘炎：限制活动→NSAID→注射激素（至腱鞘邻近的骨膜）→无效可行腱鞘切开减压术

3.化脓性滑囊炎：切口近端距腕横纹至少 1.5cm（避免损伤正中神经）飞轮海中谁是腕

腕管综合征：卡压正中神经

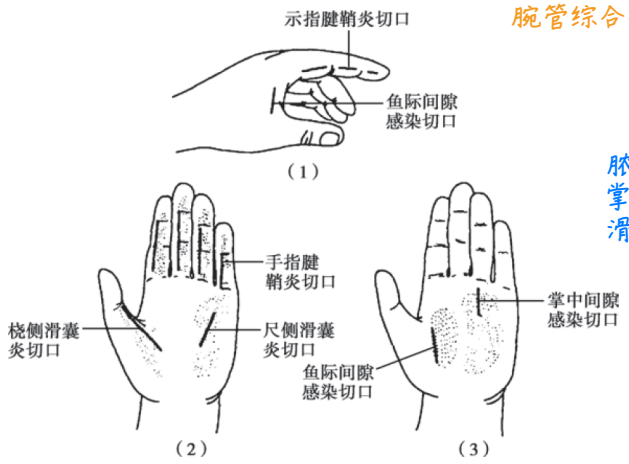
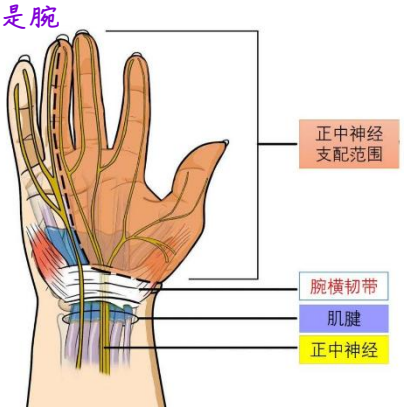


图 8-5　手指屈肌腱鞘炎、滑囊炎、掌深间隙感染的手术切口

（1）示指掌侧腱鞘炎与鱼际间隙感染的切开线　（2）手指腱鞘炎与桡、尺侧滑囊炎的切开线　（3）掌深间隙感染的切口

脓性指头炎-指节横纹；
掌深间隙感染-掌横纹；
滑囊炎-腕横纹



四、脓毒症

（旧称败血症，是由化脓菌感染引起的 SIRS、脓肿）

1.局部感染灶+突发高热或低体温+全身不适+WBC 明显↑或↓，可有感染性休克（G-杆菌发生早、持续长），可有类白血病反应（抑制骨髓造血）eg.AOSC

①**G-杆菌**（多见）：可有三低现象（血压/体温/WBC 均低），易冷休克 平时说的休克

②金葡菌：易寒战高热、皮疹、心肌炎、**迁徙/转移性脓肿**（特征）脓热疹心惊

③厌氧菌：多合并需氧菌感染（坏死明显易形成脓肿）、恶臭 需氧菌好氧，更好形成厌氧环境

④真菌：结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑等栓塞表现 肉芽肿造成的栓塞表现



不能因为高热，WBC明显↑就排除G-杆菌（看到了低体温、WBC↓，不要否定感染，感染也可导致三低现象，三低现象在G-杆菌中发生的概率大）

2.检查

①血培养：寒战发热时进行，多次阴性考虑厌氧菌、真菌 不容易培养出来

VS感染性心内膜炎：持续菌血症，无需在寒战发热时进行血培养

②脓液/穿刺液培养、导管内采样送检（如肠外营养中心静脉导管相关感染）

eg.化脓性关节炎→关节穿刺培养

细菌性肝脓肿→肝穿刺培养

3.1h 内静脉用抗生素+处理原发感染灶（**休克者同时补充血容量**）